EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 88989
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-07-22 08:57:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA GRACIELA GATICA URIBE			RUN	: 7.692.648-4
F.Nac	: 02-03-1954	Edad	: 70 AÑOS, 4 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: SAN CARLOS			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: PARTICULAR	Teléfono	: 949020094		
Fecha Ingreso	: 2024-07-14	Fecha Egreso	: 2024-07-22 08:57:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R50.9-FIEBRE, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) Sd febril resuelto (neumonia bilateral)
2) Melanoma con MMT cerebrales, pulmonares y oseas en cuidados paliativos
3) Epilepsia 2° a MMT cerebral
4) ACV isquemico secuelar
5) Obs Diabetes esteroidea
6) DLP 2°

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. R50.9-FIEBRE, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos, consulta el 13/07 por cuadro de CEG, sensacion febril, orinas turbias, de mal olor, ausencia de deposiciones desde hace 6 dias.
Examenes de lab al ingreso -> glicemia 271; albumina 3,7; crea 0,4; ac urico 3,4; LDH 620; GGT 396; TG 803; PCR 8,1; uremia 61; BUN 29; Na/K/Cl 134/5,1/99; Gb 17,6; Hb/Hcto 31.5; plaq 307000; segment 84%; GSV pH 7,43; orina normal.
Se procede a toma de HC; inicio de terapia ATB e ingreso para estudio.
Se solicita TAC TAP 14/07 -> Esteatosis hepatica difusa, colecistolitiasis, quistes corticales renales bilaterales de aspecto simple, nodulo solido en LSD, posiblemente metastasico, bandas atelectasicas bilaterales, opacidades bilaterales con alteracion en vidrio esmerilado, inespecifico, de eventual origen inflaamtorio-infeccioso.
Durante estadia con aprametros inflamatorios en descenso, con presentacion de peaks febriles intermitentes
Paciente HDN estable, afebril desde hace 48 hrs, con buena tolerancia a alimentacioN VO acorde a familiares, diuresis 700 cc PM, deposiciones 100 cc PM, se aspecto normal
Examenes de lab 22/07 -> crea 0,4; lactato 2,2; PCR 19; Na/K/Cl 133/4.8/101; Hb/HCto 8.1/24.6; Gb 9,6; plaq 209000; segment 80%;
HC (-)
Ex fisico -> Sopor superficial, levemente mas reactiva en comparativa a dias previos, mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 seg
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: HC negativos, con parametros inflamatorios en descenso, se procedera a cambio a ATB y completar 12 dias de terapia ATB a traves de HODOm

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo: relativo asistido/ prevencion de UPP
2. Régimen:papilla + liquido asistido

3. Levetiracetam 500 mg 3 comp c/12 horas por 3 dias
4. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 3 dias
5. Cotrimoxazol forte 1 comp Lunes-Miércoles-Viernes
6. Calcio un comp al dia por 3 dias VO
7. Omeprazol 40mgrs vo dia por 3 dias
8. Ciprofibrato 100mgrs dia por 3 dias
9. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO SOS por 3 dias
10. Lactulosa 20 cc c/8hrs VO por 3 dias
11. Metadona 10 mg 1-1/2-1/2-1/2 VO por 3 dias
12. Pregabalina 75 mg, medio comp al dia VO por 3 dias
13. Morfina 4 gotas VO SOS
14. Examenes de lab 25/07

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO